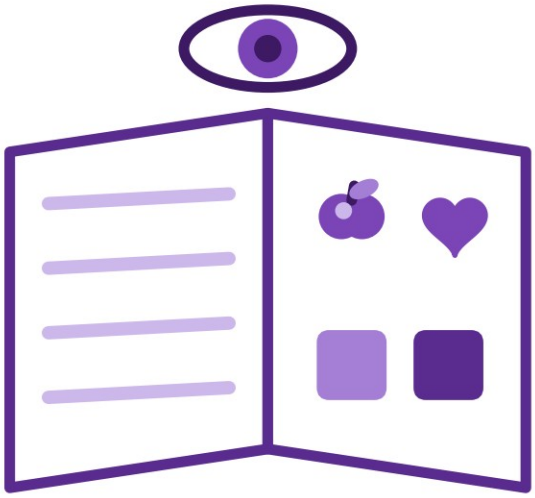


CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 5 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 4
S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 4
S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 8
S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 11
Partie II – Les corrigés détaillés 15
Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 15
Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 21
Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 26
Grille d'auto-évaluation 33

Cahier d'annales E5 – chapitre 5

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 5 porte sur la littératie en santé : définitions (Sørensen, Nutbeam, littératie alimentaire), données françaises (HLS19, illettrisme, illectronisme), lien avec les inégalités sociales de santé, repérage sans stigmatisation (précautions universelles), adaptation des messages et des supports (écriture claire, FALC, pictogrammes, lisibilité, accessibilité numérique), vérification de la compréhension (faire dire), numératie et littératie numérique. Le jury vérifie que le candidat sait **mesurer** les difficultés d'un public sans le juger (questionnaire oral, test de compréhension, indice de lisibilité), **adapter** un support et une animation, puis **vérifier** que le message a été compris, en considérant que la clarté est d'abord la responsabilité du professionnel et de l'organisation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses ressources (langues parlées, entraide, oral, smartphone), ses obstacles (écrit, chiffres, démarches en ligne, handicap) et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque donnée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme une notion du chapitre (dimension de Sørensen, niveau de Nutbeam, numératie, illectronisme, précautions universelles, lisibilité) et l'adaptation qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'association « Chemins de santé » (structure fictive), qui emploie deux médiatrices en santé auprès des familles des deux aires d'accueil des gens du voyage de l'agglomération du Val de Sorne (territoire fictif). La responsable vous confie une demande issue d'une réunion avec le service de protection maternelle et infantile (PMI) et le cabinet dentaire mobile du département : « Beaucoup d'enfants ont des caries, ils boivent des sodas et des jus toute la journée. Les mères nous disent qu'elles ne comprennent pas nos dépliants, et plusieurs adultes diabétiques ne savent pas lire leurs ordonnances. Nos documents ne servent à rien. » Vous devez analyser la situation sous l'angle de la littératie en santé, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – Le territoire, le public et les moyens

- Deux aires d'accueil (64 emplacements au total), gérées par l'agglomération ; en hiver, environ 52 familles sont présentes, soit environ 220 personnes, dont 140 adultes de 18 ans ou plus. Les familles voyagent surtout d'avril à octobre.
- Chaque emplacement dispose d'un bloc sanitaire et d'un branchement électrique payant ; les familles cuisinent dans leur caravane ou à l'extérieur. Les courses se font au supermarché de la zone commerciale, à 3 km.
- La scolarisation des enfants est irrégulière, en particulier au collège ; une partie des adultes n'a pas ou peu été scolarisée.
- Ressources : deux médiatrices, dont l'une est elle-même issue de la communauté ; un local associatif sur l'aire principale (une salle de 30 m², un évier, deux plaques électriques, un réfrigérateur) ; partenaires : PMI, cabinet dentaire mobile, maison de santé, centre social, Éducation nationale.
- Budget de l'action : 1 800 € pour l'année (hors salaires).

Document 2 – Questionnaire administré oralement par les médiatrices (données fictives)

Les médiatrices ont interrogé 74 adultes volontaires, en entretien oral, avec six questions inspirées de l'enquête HLS19 (« Est-ce facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile pour vous de… ») et trois questions sur l'écrit et le numérique.

Question	Réponses « plutôt difficile » ou « très difficile » (n = 74)
Comprendre la notice d'un médicament	41
Remplir un formulaire administratif (CAF, Assurance maladie)	52

Question	Réponses « plutôt difficile » ou « très difficile » (n = 74)
Trouver une information de santé sur internet	49
Juger si une information de santé vue à la télévision ou sur les réseaux sociaux est fiable	44
Comprendre ce que dit le médecin pendant la consultation	18
Comprendre les informations sur les emballages des aliments	46

Écrit et numérique	Réponses « oui » (n = 74)
Possède un smartphone	68
Sait utiliser une application de santé (Mon espace santé, prise de rendez-vous)	15
Déclare lire le français couramment	30

À partir de leurs réponses, les médiatrices ont classé les 74 adultes selon le niveau de littératie en santé générale (méthode de score simplifiée inspirée du HLS19) : insuffisant 26 ; problématique 28 ; suffisant 20.

Document 3 – Le dépliant de la PMI « Les boissons sucrées » et un test de compréhension (données fictives)

- Version actuelle : 180 mots, 7 phrases, 324 syllabes ; texte justifié en police de 9 points ; trois sigles (PNNS, OMS, AJR) ; une photo de bouteilles sans légende.
- Version réécrite par les médiatrices et vous : 90 mots, 13 phrases, 130 syllabes ; police de 14 points ; quatre pictogrammes (verre d'eau, bouteille de soda, morceaux de sucre, dent).
- Test auprès de 20 mères (10 par version, puis croisement des versions) : à la question « Combien de verres de jus de fruits par jour au maximum pour un enfant ? », 6 bonnes réponses sur 20 avec la version actuelle ; 16 sur 20 avec la version réécrite.
- Indice de lisibilité de Kandel et Moles : L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots).

Document 4 – Caries et boissons sucrées chez les enfants vus par le cabinet dentaire mobile (données fictives)

Le cabinet dentaire mobile a examiné 60 enfants de 3 à 11 ans des deux aires. Les parents ont indiqué si l'enfant boit des sodas ou des boissons sucrées tous les jours.

- Enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours : 34, dont 21 ont au moins une carie non soignée.
- Enfants qui n'en boivent pas tous les jours : 26, dont 6 ont au moins une carie non soignée.

Document 5 – Paroles recueillies pendant le stage

« Les papiers, c'est ma fille qui les lit. Elle a douze ans, elle sait mieux que moi. » (Mme R., 41 ans)

« Le docteur parle vite. Je dis oui, oui, et après je demande à la pharmacienne. » (M. L., 58 ans, diabétique)

« Le jus, c'est bon pour les enfants, c'est des fruits. C'est marqué dessus. » (Mme D., 29 ans)

« Les vidéos sur le téléphone, ça on regarde, oui. Pas les papiers. » (Mme S., 34 ans)

« On n'aime pas trop les bureaux. Si c'est Sandra qui vient ici, on écoute. » (Mme P., 52 ans, à propos de la médiatrice)

« Mon garçon, il a eu mal aux dents tout l'hiver. On attendait de repartir pour voir un dentiste ailleurs. »

(Mme V., 36 ans)

Document 6 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Un agent de la mairie vous demande la liste des familles « dont les enfants ont des caries » pour « signaler les familles négligentes ». Une start-up propose de prêter gratuitement des tablettes équipées de son application de « coaching nutritionnel », en échange des données d'utilisation des familles. Une étudiante en journalisme souhaite photographier les enfants pendant votre atelier pour un reportage sur « les voyageurs et la malbouffe ».

Document 7 – Cadre et repères (données réelles)

- La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage organise les aires d'accueil ; la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a supprimé les titres de circulation qui leur étaient imposés.
- La médiation en santé est reconnue par l'article L. 1110-13 du Code de la santé publique (loi du 26 janvier 2016) ; la HAS a publié en 2017 un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques.
- Enquête HLS19 (résultats français publiés en 2021) : environ 44 % des adultes ont une littératie en santé générale limitée (problématique ou insuffisante).
- Insee (enquête 2025, publiée le 19 février 2026) : 7 % des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme et 34 % ont des difficultés numériques.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et idéalement à moins de 5 %, notamment pour prévenir la carie dentaire.
- Santé publique France a publié en 2018, et mis à jour en février 2025, le guide « Communiquer pour tous » pour une information en santé accessible.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation des adultes ; calculez la part de littératie limitée et comparez-la avec la donnée nationale. Classez les six questions selon les quatre compétences du modèle de Sørensen et posez le diagnostic. (2 pts)
2. Calculez l'indice de lisibilité des deux versions du dépliant et les taux de bonnes réponses au test de compréhension (document 3). Interprétez les résultats et dites ce que chaque mesure apporte et ne dit pas. (2 pts)
3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : niveaux de Nutbeam, littératie alimentaire, numératie, illectronisme, littératie organisationnelle, inégalités sociales de santé et ressources du public. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)
5. Présentez le plan d'action sur un an, construit avec les familles et les médiatrices, en tenant compte des périodes de voyage, et un budget qui respecte les 1 800 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez la prévalence des caries, le risque relatif de carie selon la consommation quotidienne de boissons sucrées et son intervalle de confiance à 95 %, avec la formule : $IC = \exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$. Interprétez. Pourquoi ne peut-on pas conclure à une relation de cause à effet ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'adultes ayant une littératie limitée et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points, avec correction pour une population de 140 adultes. Présentez trois limites d'un questionnaire administré oralement par les médiatrices. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la littératie en santé, la santé des gens du voyage et la communication accessible : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 6 (secret professionnel, stigmatisation, données personnelles, droit à l'image des mineurs) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez des supports et des canaux adaptés à ce public (oral, vidéo, pictogrammes, médiation) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le centre social « La Passerelle » de Montclar (structure fictive) organise des ateliers sociolinguistiques (ASL) : des adultes arrivés en France depuis quelques mois ou quelques années y apprennent le français à partir de situations de la vie quotidienne (faire ses courses, aller chez le médecin, inscrire un enfant à l'école). La formatrice bénévole constate que le thème « alimentation » motive beaucoup le groupe : « Ils savent tous cuisiner, souvent très bien, mais ils sont perdus devant les étiquettes et les conseils qu'on leur donne à la PMI. » Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui serve à la fois à **apprendre des mots et des gestes en français** et à **découvrir des repères nutritionnels** utiles à toute la famille, à partir d'un menu simple et économique.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 apprenants de 24 à 63 ans (6 femmes, 2 hommes) ; niveau de français oral A1 à A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; langues parlées : arabe (3), tamoul (2), dari (1), soninké (1), portugais (1).
- Trois apprenants ne lisent pas l'alphabet latin : une femme lit l'arabe, un homme lit le tamoul, une femme n'a jamais été scolarisée.
- Madame A. est enceinte de cinq mois ; Madame N. a un diabète de type 2 traité par comprimés ; Monsieur H. est végétarien ; cinq apprenants ne mangent pas de porc ; personne ne signale d'allergie.
- Cuisine du centre social : 4 plaques à induction, 1 four, 1 four à micro-ondes, 4 postes de travail pour 2 personnes, 1 réfrigérateur ; la formatrice est présente pendant tout l'atelier.
- Budget denrées : au plus 2,00 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 apprenants, la formatrice et vous).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 15, de 9 h 15 à 11 h 30, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : pois chiches mijotés aux épinards et à la tomate, riz complet.

Dessert : salade d'oranges à la cannelle, yaourt nature.

Le candidat réalise le plat et la salade d'oranges. Il présente aussi les adaptations pour Madame A. (grossesse) et pour Madame N. (diabète de type 2), et une version « à refaire à la maison » avec deux plaques et des produits de base.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pois chiches en conserve, poids égoutté (boîte de 265 g égouttés)	120 g	sans perte	2,20 € le kg égoutté

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Épinards en branches surgelés (sachet de 1 kg)	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Tomates pelées en conserve, égouttées	80 g	sans perte	1,60 € le kg
Oignons	30 g	10 %	1,80 € le kg
Huile d'olive vierge extra	6 g	sans perte	8,50 € le kg
Riz complet	60 g (cru)	sans perte	2,90 € le kg
Oranges	150 g	30 %	2,20 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,22 € le pot
Ail, cumin, curcuma, cannelle, citron, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pois chiche, appertisé, égoutté	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	1,15	0,1
Epinard, haché ou purée ou en branches, surgelé, cru	28	3,32	1	0,83	0,54	2,95	0,14	1,89	15,3
Tomate, pelée, appertisée, égouttée	16,4	0,9	1,61	1,6	0,28	1,27	0,33	0,57	12,6
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	traces	3,9
Huile d'olive vierge extra	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,05	0
Riz complet, cru	350	7,02	71,4	0	2,8	5	0,01	< 1	0
Orange, chair sans peau, sans pépins, crue	42	0,75	8,03	7,6	< 0,5	2,7	< 0,013	0,57	47,5
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	< 0,25	< 2

On calcule avec les poids nets (crus pour le riz, égouttés pour les conserves). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – La fiche recette utilisée jusqu'ici par le centre social (extrait)

« Émincer finement les oignons et l'ail, puis les faire revenir dans l'huile d'olive jusqu'à coloration légère avant d'incorporer les épices, qui seront torréfiées quelques instants afin de développer leurs arômes. Ajouter les tomates concassées, laisser compoter, puis incorporer les épinards préalablement décongelés et les pois chiches égouttés et rincés… » La fiche complète compte 150 mots, 6 phrases et 255 syllabes ; elle ne

comporte aucune image ; les quantités sont indiquées en grammes pour 10 personnes.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Le Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l'Europe, 2001) décrit six niveaux, de A1 (utilisateur élémentaire, découverte) à C2 ; au niveau A1, une personne comprend des expressions familières et quotidiennes et des énoncés très simples.
- Les règles européennes du « Facile à lire et à comprendre » (Inclusion Europe, 2009) et le guide « Communiquer pour tous » (Santé publique France, 2018) recommandent des phrases courtes, des mots courants, une idée par phrase et des images qui disent la même chose que le texte.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour ; au moins cinq fruits et légumes par jour.
- Pendant la grossesse, les recommandations officielles conseillent notamment d'éviter les fromages au lait cru, les produits de la mer crus et la charcuterie à la coupe (prévention de la listériose et de la toxoplasmose), et de laver soigneusement les légumes et les fruits.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, y compris dans les denrées non préemballées.
- Indice de lisibilité de Kandel et Moles : L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins et les ressources de ce public (savoir-faire culinaires, langues, lecture, numératie, situations de santé) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, dont au moins un objectif de langue. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Calculez l'indice de lisibilité de la fiche du document 5 ; rédigez une fiche recette « facile à lire » en six étapes illustrées au plus, indiquez ce que montre chaque image, et vérifiez sa lisibilité si elle compte 84 mots, 14 phrases et 118 syllabes. Présentez les adaptations demandées et la version « à refaire à la maison ». (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas (plat, salade d'oranges et yaourt) en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame A. (2 pts)
5. Expliquez, avec les notions du chapitre (littératie fonctionnelle, interactive et critique, littératie alimentaire, numératie, précautions universelles), comment l'atelier développe à la fois le français et les compétences alimentaires, et pourquoi il ne faut pas confondre maîtrise du français et compétences culinaires. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant les binômes (langues, lecture) et les temps de langage. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (imagier des ingrédients et des gestes, objets réels, démonstration, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation utilisable sans lecture. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, lavage des fruits, conserves, riz cuit), la gestion des allergènes et les précautions pour Madame A., et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et la salade d'oranges ; dressez une assiette et un bol de dessert. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, mots appris, gestes et repères retenus, intention de refaire), sans recours à l'écrit pour les participants. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique à l'association « Regards partagés » de Valbonne-sur-Lize (structure fictive), qui accompagne 120 adhérents adultes aveugles ou malvoyants. Le président, lui-même malvoyant, vous explique : « Nous ne pouvons pas lire les dates, les prix, les tableaux nutritionnels. Beaucoup d'entre nous mangent des plats tout prêts, parce qu'ils ont peur de se brûler ou de se couper. Et les campagnes de santé, avec leurs affiches et leurs sites, ne sont pas faites pour nous. » L'association souhaite un projet « Bien manger en autonomie », comprenant un atelier culinaire adapté. Vous devez analyser la situation, concevoir le projet et animer un premier atelier.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Document 1 – Le public, la structure et les moyens

- 120 adhérents de 22 à 88 ans ; environ un tiers sont aveugles, deux tiers malvoyants (basse vision : lecture impossible ou très lente sans aide) ; 58 % vivent seuls.
- Outils utilisés par une partie des adhérents : lecteur d'écran sur smartphone, assistant vocal, loupe électronique, application de reconnaissance de texte ; quelques adhérents lisent le braille.
- Local : une cuisine pédagogique de 4 postes, plaques à induction, four à hauteur, contrastes de couleurs sur les plans de travail ; deux bénévoles formés à l'accompagnement.
- Partenaires : centre de rééducation basse vision (ergothérapeute, instructrice en autonomie dans la vie journalière), supermarché voisin, centre communal d'action sociale.
- Budget : 2 000 € pour l'année (hors salaires).

Document 2 – Enquête téléphonique auprès des adhérents (données fictives)

45 adhérents ont répondu à un questionnaire par téléphone (passation orale, 15 minutes).

Question	Réponses « oui » (n = 45)
Je ne peux pas lire les dates (DLC, DDM) sur les emballages	35
Je ne peux pas lire le tableau nutritionnel	39
J'utilise une application ou un assistant vocal pour lire les étiquettes	17
Je cuisine seul au moins 4 fois par semaine	28
Je me suis brûlé ou j'ai eu très peur de me brûler en cuisinant cette année	20
Je mange surtout des plats préparés	19
Je suis satisfait de mon alimentation	22

Croisement : parmi les 28 adhérents qui cuisinent seuls au moins 4 fois par semaine, 16 se sont brûlés ou ont eu très peur de se brûler ; parmi les 17 autres, 4.

Document 3 – Trois supports de prévention examinés (données fictives)

Support	Taille de police	Couleur du texte / du fond	Luminance relative du texte	Luminance relative du fond
A – Dépliant municipal « Manger mieux »	9 points	gris moyen sur blanc	0,216	1,000
B – Affiche d'un supermarché « Nos produits santé »	12 points	jaune pâle sur blanc	0,927	1,000
C – Fiche de l'association	16 points	noir sur blanc	0,000	1,000

Rapport de contraste selon les règles WCAG : (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance relative la plus claire et L2 la plus foncée. Seuil minimal (niveau AA) : 4,5 pour un texte courant, 3 pour un grand texte (18 points, ou 14 points en gras).

Audit du site internet de la mairie, page « Santé » : 5 critères d'accessibilité sur 12 sont respectés (les images n'ont pas de texte alternatif, la vidéo n'est pas sous-titrée ni audiodécrite, les liens « cliquez ici » ne disent pas où ils mènent).

Document 4 – Paroles d'adhérents

« Au magasin, je demande au caissier de me lire la date. Il est pressé, alors je n'ose plus. » (Mme G., 67 ans, malvoyante)

« Mon téléphone me lit l'étiquette, mais il me lit tout, même la publicité ; je m'y perds. » (M. T., 34 ans, aveugle)

« Je faisais très bien la cuisine. Depuis que je ne vois plus, je réchauffe des barquettes. » (Mme L., 79 ans)

« Les dépliants de la mairie, je les jette, je ne peux pas les lire. » (M. B., 58 ans)

« Ce qu'il me faudrait, c'est qu'on me montre, avec les mains. » (Mme R., 46 ans)

Document 5 – Deux situations rencontrées pendant le stage

Une entreprise propose de financer l'atelier si l'association recommande son application payante de lecture d'étiquettes dans sa lettre d'information. Un bénévole souhaite filmer l'atelier et diffuser la vidéo sur la page publique de l'association « pour montrer que c'est possible ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d'accessibilité, y compris des services de communication en ligne des organismes publics (article 47).
- Le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) s'appuie sur les règles internationales WCAG (W3C) ; la version 2.1 des WCAG date de 2018.
- La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), ratifiée par la France en 2010, reconnaît le droit à l'accès à l'information.
- La directive européenne 2019/882 sur les exigences d'accessibilité des produits et services (« Acte européen sur l'accessibilité ») s'applique depuis le 28 juin 2025 à certains produits et services, dont le commerce électronique.

Travail à faire – temps 1

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant ce qui relève des personnes, des produits (étiquetage) et de l'environnement (supports, magasins, sites). (2,5 pts)

2. Calculez le rapport de contraste des trois supports et le taux de conformité du site ; concluez sur leur accessibilité et proposez les corrections. Expliquez pourquoi une « bonne » lisibilité au sens de l'indice de Kandel et Moles ne suffit pas pour ce public. (2,5 pts)
3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : dimensions de Sørensen, littératie alimentaire, littératie numérique et outils d'aide, littératie organisationnelle, précautions universelles. (2 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels avec indicateurs ; présentez un plan d'action sur un an et un budget qui respecte les 2 000 €. (4 pts)
5. Calculez le risque relatif de brûlure ou de peur de se brûler selon la fréquence de cuisine solitaire et son intervalle de confiance à 95 % (même formule que dans les autres sujets). Concluez avec prudence. Calculez l'intervalle de confiance de la proportion d'adhérents qui ne peuvent pas lire le tableau nutritionnel, et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (population de 120). (3 pts)
6. Organisez une veille sur l'accessibilité de l'information alimentaire et sur la déficience visuelle (sources, outils, fréquence). (2 pts)
7. Analysez les deux situations du document 5 et rédigez vos réponses ; indiquez comment rendre accessibles votre exposé et vos supports. (2 pts)

Qualité de l'expression, vocabulaire et sources datées : 2 pts.

Temps 2 – L'atelier culinaire « Cuisiner en sécurité, sans voir ou en voyant peu »

Document 7 – Le groupe et les contraintes

- 6 adhérents de 34 à 79 ans : 2 aveugles, 4 malvoyants ; Mme L. (79 ans) a un diabète de type 2 ; M. B. (58 ans) a une hypertension artérielle ; personne ne signale d'allergie.
- 2 bénévoles formés et l'ergothérapeute du centre de rééducation sont présents ; 4 postes de travail.
- Budget denrées : au plus 2,50 € par portion ; 10 portions (6 adhérents, 2 bénévoles, l'ergothérapeute et vous).
- Durée avec le public : 2 h 30, repas compris.

Document 8 – Menu imposé et grammages (données construites pour le sujet)

Plat : poulet mariné au yaourt et au citron, cuit au four ; semoule ; carottes râpées au jus d'orange. Dessert : banane écrasée au fromage blanc et à la cannelle.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Filet de poulet sans peau	100 g	sans perte	11,50 € le kg
Yaourt nature (marinade)	30 g	sans perte	2,20 € le kg
Citron (jus)	5 g de jus	60 %	3,00 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Semoule de blé dur	60 g (crue)	sans perte	1,90 € le kg
Carottes	100 g	15 %	1,40 € le kg
Oranges à jus (jus)	30 g de jus	55 %	2,00 € le kg
Bananes	80 g	35 %	2,00 € le kg
Fromage blanc nature 2-3 % MG	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Ail, cumin, cannelle, persil, sel, poivre	–	–	forfait 0,90 € pour l'atelier

Document 9 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Jus de citron, pur jus	29,4	0,4	6,1	2,4	0,29	0,4	0,053
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Semoule de blé dur, crue	350	11,8	69,8	1	1,28	3,7	0,0025
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Jus d'orange, pur jus	45,4	0,61	9,61	9,61	0,11	0,28	0,012
Banane, chair sans peau, crue	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088

Travail à faire – temps 2

8. Identifiez les besoins du groupe et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

9. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; vérifiez le budget. Calculez l'apport d'une portion du repas et la répartition de l'énergie ; commentez pour Mme L. et M. B. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique du plat et une version accessible de la recette (audio, gros caractères à fort contraste, repères tactiles) ; présentez les adaptations du poste de travail et des gestes (couper, râper, verser un liquide chaud, utiliser le four) proposées avec l'ergothérapeute. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté des 3 heures, les méthodes d'animation (guidage verbal précis, main sur main avec accord, repères « en horloge » dans l'assiette, « faire dire » et « faire faire ») et une grille de dégustation orale. (4 pts)

12. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (volaille crue, cuisson à cœur, rangement constant des ustensiles, brûlures et coupures), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (3 pts)

13. Réalisez le plat et le dessert ; proposez l'évaluation de l'atelier (autonomie, sécurité, plaisir, intention de refaire). (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la capacité à décrire des difficultés de littératie sans juger les personnes, à repérer aussi leurs **ressources** (oral, entraide, smartphone, confiance dans la médiatrice), et à proposer des actions qui changent d'abord les **supports** et l'**organisation** plutôt que les personnes. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des notions (Sørensen, Nutbeam, numératie, illectronisme, précautions universelles, littératie organisationnelle) et le respect strict du secret professionnel. Il pénalise les jugements culturels (« ils ne s'intéressent pas à leur santé »), la confusion entre littératie et intelligence, et toute action qui désigne ou fiche des familles.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs, modèle de Sørensen et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire oral (n = 74)

- Comprendre la notice d'un médicament : 41 / 74 × 100 = **55,4 %** trouvent cela difficile.
- Remplir un formulaire administratif : 52 / 74 × 100 = **70,3 %**.
- Trouver une information de santé sur internet : 49 / 74 × 100 = **66,2 %**.
- Juger la fiabilité d'une information de santé vue dans les médias : 44 / 74 × 100 = **59,5 %**.
- Comprendre ce que dit le médecin : 18 / 74 × 100 = **24,3 %**.
- Comprendre les informations sur les emballages : 46 / 74 × 100 = **62,2 %**.
- Possède un smartphone : 68 / 74 × 100 = **91,9 %** ; sait utiliser une application de santé : 15 / 74 × 100 = **20,3 %** ; lit le français couramment : 30 / 74 × 100 = **40,5 %**.
- Parmi les possesseurs de smartphone, utilisateurs d'une application de santé : 15 / 68 × 100 = **22,1 %**.
- Niveaux : insuffisant 26 / 74 = **35,1 %** ; problématique 28 / 74 = **37,8 %** ; suffisant 20 / 74 = **27,0 %**. Littératie limitée : (26 + 28) / 74 × 100 = **73,0 %**, contre environ **44 %** en population générale (HLS19, 2021), soit 73,0 / 44 ≈ **1,7 fois** plus.
- Taux de participation : 74 / 140 × 100 = **52,9 %** des adultes.

Question	Compétence (Sørensen, 2012)	Domaine
Comprendre la notice d'un médicament	Comprendre	Soins
Remplir un formulaire administratif	Appliquer (agir, communiquer une information)	Soins et accès aux droits
Trouver une information sur internet	Accéder	Prévention, promotion de la santé
Juger la fiabilité d'une information des médias	Évaluer	Promotion de la santé
Comprendre le médecin	Comprendre	Soins
Comprendre les emballages	Comprendre et appliquer	Prévention (alimentation)

Diagnostic. Près des trois quarts des adultes interrogés (73,0 %) ont une littératie en santé limitée, une proportion bien supérieure à la moyenne nationale. Les difficultés portent surtout sur l'**écrit** (formulaires 70,3 %, notices 55,4 %, emballages 62,2 %) et sur le **numérique** (internet 66,2 % ; seulement 20,3 % savent utiliser une application de santé, alors que 91,9 % ont un smartphone). L'**évaluation** de l'information est difficile pour 59,5 %

: c'est la compétence la plus exigeante, et elle explique des croyances comme « le jus, c'est des fruits » (Mme D.). À l'inverse, l'**oral** fonctionne mieux : seuls 24,3 % ont du mal à comprendre le médecin, et les familles regardent volontiers des vidéos (Mme S.). Les ressources sont réelles : l'entraide familiale (même si faire lire les papiers par une enfant de 12 ans pose problème), la confiance dans la médiatrice, l'usage quotidien du smartphone pour la vidéo et la messagerie.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Caries fréquentes chez les enfants, consommation quotidienne de boissons sucrées (repères de l'OMS, 2015) ; littératie limitée bien au-dessus de la moyenne nationale
Ressenti	« Le docteur parle vite » ; peur ou gêne dans les bureaux ; douleur dentaire de l'enfant
Exprimé	Préférence pour la vidéo et pour la venue de la médiatrice sur l'aire
Comparatif	73,0 % de littératie limitée contre environ 44 % en France

Question 2 – Lisibilité et test de compréhension (2 pts)

Calcul posé – Indice de Kandel et Moles et test auprès de 20 mères

- Version actuelle : mots par phrase 180 / 7 = **25,71** ; syllabes par mot 324 / 180 = **1,80**. L = 207 − 1,015 × 25,71 − 73,6 × 1,80 = 207 − 26,10 − 132,48 = **48,42** : texte **difficile**.
- Version réécrite : mots par phrase 90 / 13 = **6,92** ; syllabes par mot 130 / 90 = **1,44**. L = 207 − 1,015 × 6,92 − 73,6 × 1,444 = 207 − 7,03 − 106,31 = **93,66** : texte **très facile**.
- Gain : 93,66 − 48,42 = **45,24 points**.
- Test : bonnes réponses 6 / 20 × 100 = **30 %** avec la version actuelle ; 16 / 20 × 100 = **80 %** avec la version réécrite, soit **+ 50 points**.

Interprétation. La réécriture fait passer le texte de « difficile » à « très facile » et multiplie par 80 / 30 ≈ **2,7** la proportion de bonnes réponses. Les deux mesures sont complémentaires. L'indice de lisibilité mesure seulement la **longueur** des phrases et des mots : il ne dit rien du sens, des sigles, de la taille de la police, des images, ni de la culture du public, et il ne s'applique pas à une personne qui ne lit pas. Le **test de compréhension** auprès de personnes du public mesure ce qui compte vraiment (le message est-il compris ?), mais sur un petit effectif (20 mères) et avec une seule question. Pour ce public, où 59,5 % des adultes ne lisent pas couramment le français, un dépliant même très lisible restera insuffisant : il doit être accompagné d'une **explication orale** et d'un **support visuel ou vidéo**.

Question 3 – Analyse avec les notions du chapitre (2 pts)

- **Niveaux de Nutbeam** : la littératie **fonctionnelle** (lire une notice, une étiquette) est limitée pour une majorité ; la littératie **interactive** est une force (échanger avec la médiatrice, demander à la pharmacienne) ; la littératie **critique** (juger la publicité « 100 % fruits ») est à développer, en groupe.
- **Littératie alimentaire** (Vidgen et Gallegos, 2014) : les compétences de **préparation** et de **partage** sont présentes ; la **sélection** (lire les emballages, repérer le sucre) est difficile.
- **Numératie** : les grammes de sucre pour 100 mL ne parlent pas ; les morceaux de sucre et les verres, oui.
- **Illectronisme** : avoir un smartphone ne suffit pas (20,3 % savent utiliser une application de santé) ; la dématérialisation des démarches (Mon espace santé, prise de rendez-vous) **exclut** une partie des familles.
- **Littératie organisationnelle** : les documents de la PMI, les formulaires et les bureaux ne sont pas adaptés ; la mobilité (départ au printemps) rompt le suivi ; la responsabilité est d'abord celle des institutions (« nos documents ne servent à rien »).
- **Inégalités sociales de santé** : faible scolarisation, conditions de vie sur les aires, discriminations et méfiance envers les institutions ; une communication écrite standard **creuse le gradient** (chapitre 2) ; l'**universalisme proportionné** justifie des moyens renforcés (médiation, oral, venue sur l'aire).

- **Enfant interprète** : faire lire les papiers par une enfant de 12 ans inverse les rôles et expose à des erreurs ; il faut proposer d'autres solutions (médiatrice, lecture à voix haute, interprétariat si besoin).

Problème central : les messages de santé bucco-dentaire et alimentaire destinés aux familles des aires d'accueil sont peu compris et peu utilisables, parce qu'ils reposent sur l'écrit et le numérique. Causes : supports écrits complexes, démarches en ligne, faible scolarisation, méfiance envers les institutions, publicité trompeuse, mobilité. Conséquences : consommation quotidienne de boissons sucrées, caries non soignées, douleurs, recours tardif aux soins, mauvaise compréhension des traitements chez les adultes diabétiques.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer la santé bucco-dentaire et nutritionnelle des enfants des aires d'accueil du Val de Sorne en rendant les informations de santé accessibles et utilisables par les familles, d'ici un an.

Objectif	Indicateur	Valeur de départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : réduire la consommation quotidienne de boissons sucrées des enfants de 3 à 11 ans	Part des enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours (déclaration des parents)	34 / 60 = 56,7 %	40 %	12 mois
Spécifique 2 : rendre les supports et les démarches de santé compréhensibles par les familles	Part de bonnes réponses aux tests de compréhension des supports	30 %	80 % au moins pour chaque support	6 mois
Opérationnel 1 : produire avec 6 mères trois vidéos de 2 minutes (boissons, brossage des dents, rendez-vous dentaire), diffusées par messagerie	Nombre de vidéos produites et nombre de familles destinataires	0	3 vidéos, 40 familles	4 mois
Opérationnel 2 : animer 6 ateliers « boissons et goûters » sur l'aire, avec morceaux de sucre et dégustation d'eaux aromatisées maison	Nombre d'ateliers et de participants ; « faire dire » réussi	0	6 ateliers, 30 participants, 80 % de « faire dire » réussis	Avant le départ d'avril
Opérationnel 3 : réécrire et tester les 4 documents de la PMI les plus utilisés	Indice de lisibilité et test de compréhension	L ≈ 48 ; 30 %	L ≥ 80 ; 80 % de bonnes réponses	3 mois
Opérationnel 4 : accompagner 20 familles dans la prise d'un rendez-vous dentaire avant le départ du printemps	Nombre de rendez-vous honorés	–	20	Mars

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Novembre-décembre	Formation courte des médiatrices et des professionnels de la PMI à l'écriture claire et au « faire dire » ; réécriture et test des documents	Littératie organisationnelle ; précautions universelles
Décembre-février	Tournage des vidéos avec les mères volontaires (elles choisissent les mots et les images)	Participation ; littératie interactive ; canal adapté (vidéo, messagerie)
Janvier-mars	Six ateliers « boissons et goûters » sur l'aire : morceaux de sucre, verres d'eau aromatisée, comparaison de briques de jus	Numératie (morceaux de sucre) ; littératie critique (« 100 % fruits » ne veut pas dire « sans sucre »)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Février-mars	Rendez-vous dentaires accompagnés, avant le départ ; remise d'un carnet de santé enfant avec rappel illustré	Accès aux soins ; continuité malgré la mobilité
Avril-octobre	Pendant les voyages : rappels vidéo et vocaux par messagerie ; lien avec les associations des autres départements	Mobilité ; universalisme proportionné
Novembre suivant	Évaluation au retour des familles ; restitution collective sur l'aire	Évaluation participative

Poste	Coût
Réalisation et montage de 3 vidéos (location de matériel, sous-titrage)	350 €
Impression de supports illustrés et plastifiés (pictogrammes, calendrier de brossage)	200 €
Denrées pour 6 ateliers (60 € par atelier)	360 €
Matériel pédagogique (verres doseurs, morceaux de sucre, carafes, gobelets)	120 €
Kits de brossage (60 kits à 3 €)	180 €
Bons d'achat pour les mères relais (participation à la conception)	300 €
Jeux et outils pédagogiques (pédagothèque, imagiers)	150 €
Déplacements	140 €
Total	**1 800 €**

Vérification : 350 + 200 + 360 + 120 + 180 + 300 + 150 + 140 = **1 800 €** ✓.

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Prévalence, risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Caries et boissons sucrées (n = 60)

Notations : a = 21 (boissons quotidiennes et carie), a + b = 34 ; c = 6 (sans boissons quotidiennes et carie), c + d = 26.

- Prévalence des caries non soignées : (21 + 6) / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Risque chez les exposés : 21 / 34 = **61,8 %** ; chez les non-exposés : 6 / 26 = **23,1 %**.
- RR = 0,618 / 0,231 = **2,68**.
- ln RR = ln 2,68 = 0,984 ; erreur type = √(1/21 − 1/34 + 1/6 − 1/26) = √(0,0476 − 0,0294 + 0,1667 − 0,0385) = √0,1464 = **0,383**.
- IC 95 % = exp(0,984 ± 1,96 × 0,383) = exp(0,984 ± 0,750) = [exp(0,234) ; exp(1,734)] = **[1,26 ; 5,67]**.

Interprétation. Les enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours ont 2,7 fois plus souvent une carie non soignée que les autres ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. On ne peut pas conclure à une relation de cause à effet : l'étude est **transversale** (exposition et carie mesurées au même moment) ; d'autres facteurs peuvent intervenir (**brossage**, dentifrice fluoré, sucreries, accès au dentiste, âge de l'enfant), qui ne sont pas pris en compte ; la consommation est **déclarée** par les parents (biais de mémoire et de désirabilité) ; l'effectif est petit (intervalle large). La relation est cependant plausible et cohérente avec les connaissances (OMS, 2015) : elle justifie l'action.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites (1,5 pt)

Calcul posé – Proportion de littératie limitée

- p = 54 / 74 = **0,730**.

- Demi-largeur : 1,96 × √(0,730 × 0,270 / 74) = 1,96 × √0,002663 = 1,96 × 0,0516 = **0,101**.
- IC 95 % = 0,730 ± 0,101 = **[62,9 % ; 83,1 %]**.
- Taille d'échantillon pour ± 5 points : n0 = 1,96² × 0,730 × 0,270 / 0,05² = 3,8416 × 0,1971 / 0,0025 = **303** ; correction pour une population de 140 : n = 303 / (1 + (303 − 1) / 140) = 303 / 3,157 = **96** adultes.

Avec 74 répondants, la précision est d'environ ± 10 points ; il faudrait interroger 96 des 140 adultes pour atteindre ± 5 points. Mais même la borne basse de l'intervalle (62,9 %) reste bien au-dessus de la moyenne nationale : la conclusion du diagnostic ne change pas.

Limites d'un questionnaire administré par les médiatrices : **désirabilité sociale** (répondre ce qui plaît à une personne connue, ou au contraire minimiser ses difficultés par fierté) ; **biais de sélection** (volontaires, familles présentes en hiver, plus proches de l'association) ; **reformulation** variable des questions d'un entretien à l'autre (biais d'enquêteur) ; méthode de score **simplifiée**, non validée, qui ne permet qu'une comparaison prudente avec HLS19.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser la veille (2 pts)

Thème	Sources fiables	Outils	Fréquence
Littératie en santé	Santé publique France (« Communiquer pour tous », dossiers littératie) ; réseau M-POHL de l'OMS Europe (HLS19 et cycle suivant) ; HAS (fiche « Faire dire », 2015 ; référentiel de médiation, 2017)	Alertes sur les sites, lettres d'information	Mensuelle
Santé des gens du voyage	Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) ; ARS (programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des plus démunis, PRAPS) ; Défenseur des droits	Lettres d'information, rapports annuels	Trimestrielle
Santé bucco-dentaire et sucres	OMS ; Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) ; Assurance maladie (examen bucco-dentaire « M'T dents »)	Bases documentaires, alertes	Trimestrielle
Outils pédagogiques	Instances régionales d'éducation et de promotion de la santé (pédagothèques) ; SantéBD (FALC)	Catalogues en ligne	À chaque projet

Diffusion : une fiche de synthèse d'une page, datée, pour l'équipe et les médiatrices, et un point oral mensuel ; les sources sont classées par date et par fiabilité.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Trois situations (1,5 pt)

- **Liste des familles « négligentes »** : les données de santé recueillies par le cabinet dentaire et par l'association sont couvertes par le **secret professionnel** ; aucune liste nominative n'est transmise à la mairie. La demande est en outre **stigmatisante** : une carie n'est pas une preuve de négligence (accès aux soins, mobilité, information inadaptée). Réponse : « Je ne peux pas vous transmettre d'information sur la santé des enfants. Je peux en revanche vous présenter des résultats anonymes et collectifs, et vous proposer de travailler avec nous sur l'accès au dentiste pour toutes les familles de l'aire. » Si un enfant est réellement en danger, la procédure relève de l'information préoccupante, par les professionnels compétents, pas d'une liste.

- **Tablettes contre données** : les données d'utilisation d'une application de « coaching nutritionnel » sont des **données personnelles**, parfois de santé (RGPD) ; elles ne peuvent pas être une contrepartie commerciale. L'outil n'a pas été évalué, il est conçu pour l'écrit et risque de culpabiliser. Réponse : refus courtois ; un éventuel partenariat devrait être sans collecte de données, sans publicité, et validé par l'association.
- **Photos d'enfants pour un reportage « malbouffe »** : le **droit à l'image** des mineurs exige l'autorisation écrite des deux parents ; le titre envisagé est **stigmatisant** et risque de rompre la confiance des familles. Réponse : pas de photo pendant l'atelier ; proposition éventuelle d'un entretien avec l'association sur ce qui fonctionne (médiation, vidéos faites par les mères), avec l'accord des familles et sans enfants identifiables.

Question 10 – Supports adaptés, trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports : vidéos courtes (2 minutes), tournées avec les mères, en français simple, sous-titrées et doublées par la voix de la médiatrice ; messages vocaux par messagerie ; affiches à pictogrammes dans le local ; objets réels (bouteilles, morceaux de sucre, verres) ; carnet illustré de rendez-vous. Pas de dépliant seul : tout support écrit est remis **avec** une explication orale et un « faire dire ».

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte et demande ; 2 min, diagnostic chiffré (73,0 % de littératie limitée, lisibilité et test de compréhension, caries et boissons) ; 1 min 30, analyse (Sørensen, Nutbeam, illectronisme, littératie organisationnelle) ; 2 min, objectifs et plan d'action ; 1 min, ce que j'ai réalisé (réécriture testée, un atelier) ; 1 min 30, évaluation et limites ; 1 min, éthique et conclusion.

Questions probables du jury : 1. Qu'est-ce que la littératie en santé selon Sørensen ? 2. Pourquoi la littératie n'est-elle pas l'intelligence ? 3. Que sont les précautions universelles ? 4. Comment avez-vous évité de stigmatiser les familles ? 5. Pourquoi un dépliant très lisible ne suffit-il pas ? 6. Quelles limites a l'indice de Kandel et Moles ? 7. Comment avez-vous testé vos supports ? 8. Pourquoi la vidéo plutôt que l'écrit ? 9. Que pensez-vous des enfants qui lisent les papiers de leurs parents ? 10. Comment tenez-vous compte de la mobilité des familles ? 11. Votre RR prouve-t-il que les sodas causent les caries ? 12. Comment avez-vous travaillé avec les médiatrices ? 13. Comment protégez-vous les données recueillies ? 14. Qu'avez-vous répondu à la mairie ? 15. Comment évaluerez-vous l'action pendant les voyages ?

> **Barème – Barème du temps 1**
>
> Partie A : 9 points (indicateurs et diagnostic 2 ; lisibilité et test 2 ; analyse 2 ; objectifs 1,5 ; plan et budget 1,5). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Confondre littératie limitée, illettrisme et illectronisme, ou additionner leurs pourcentages ; conclure que les familles « ne s'intéressent pas à leur santé » ; s'arrêter à l'indice de lisibilité sans test auprès du public ; proposer un dépliant ou un site internet comme seule solution ; oublier la mobilité des familles ; présenter le RR comme une preuve de causalité ; accepter de transmettre une liste nominative ou des photos d'enfants.

Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la capacité à concevoir un atelier qui part des **savoir-faire** des participants (ils savent cuisiner) et qui compense leurs difficultés d'**écrit** et de **langue** par l'image, l'objet, le geste et l'oral. Il valorise un bon de commande exact, une fiche recette réellement accessible (testable sans lecture), des calculs nutritionnels justes et commentés, la prise en compte de la grossesse et du diabète sans discours médicalisé, et une évaluation sans écrit. Il pénalise la confusion entre maîtrise du français et compétences culinaires, les consignes uniquement écrites et l'oubli des précautions d'hygiène.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins, ressources et objectifs (2 pts)

Domaine	Besoins	Ressources
Langue et écrit	Niveau A1-A2 à l'oral ; trois apprenants ne lisent pas l'alphabet latin, dont une personne jamais scolarisée ; vocabulaire de la cuisine et des courses en français à acquérir	Langues maternelles variées ; entraide entre apprenants ; présence de la formatrice
Alimentation	Comprendre les étiquettes et les conseils de la PMI ; repères sur les légumes secs, les céréales complètes, les fruits	Savoir-faire culinaires souvent élevés ; plats familiaux à base de légumineuses (houmous, dal, chorba)
Numératie	Passer des grammes aux mesures courantes ; comprendre un prix au kilo	Habitude de gérer un budget serré
Santé	Grossesse (Mme A.) ; diabète de type 2 (Mme N.) ; végétarisme (M. H.) ; pas de porc pour cinq personnes	Le menu imposé convient à tous : végétarien et sans porc

Objectif général : permettre aux apprenants de cuisiner et de nommer en français un repas équilibré et économique à base de légumes secs, et de comprendre des repères nutritionnels utiles à leur famille.

Objectifs opérationnels (à la fin de l'atelier, chaque apprenant sera capable de) :

1. **Langue** : nommer en français, à l'oral, au moins 8 des 12 mots de l'imagier (pois chiches, épinards, oignon, riz complet, orange, yaourt, éplucher, couper, rincer, cuire, mélanger, goûter).
2. **Gestes** : réaliser en binôme une étape de la recette à partir de la fiche en images, sans aide écrite.
3. **Repères** : montrer, avec les objets, la portion de légumes secs d'un repas et dire pourquoi l'orange est servie avec le plat (vitamine C et fer), en « faire dire ».

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Pois chiches égouttés	120 g	1 200 g	0 %	1 200 g	5 boîtes de 265 g égouttés (1 200 / 265 = 4,5)	1,200 × 2,20 = 2,64 €
Épinards surgelés	100 g	1 000 g	0 %	1 000 g	1 sachet de 1 kg	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Tomates pelées égouttées	80 g	800 g	0 %	800 g	2 boîtes de 400 g égouttés	0,800 × 1,60 = 1,28 €
Oignons	30 g	300 g	10 %	300 / 0,90 = 333 g	0,350 kg	0,333 × 1,80 = 0,60 €

Denrée	Net par portion	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Huile d'olive	6 g	60 g	0 %	60 g	Stock (bouteille entamée)	0,060 × 8,50 = 0,51 €
Riz complet	60 g	600 g	0 %	600 g	1 paquet de 1 kg	0,600 × 2,90 = 1,74 €
Oranges	150 g	1 500 g	30 %	1 500 / 0,70 = 2 143 g	2,2 kg (environ 9 oranges)	2,143 × 2,20 = 4,71 €
Yaourts nature	1 pot	10 pots	0 %	10 pots	10 pots de 125 g	10 × 0,22 = 2,20 €
Épices, ail, citron, sel	–	–	–	–	Forfait	0,80 €

Total : 2,64 + 2,60 + 1,28 + 0,60 + 0,51 + 1,74 + 4,71 + 2,20 + 0,80 = **17,08 €** ; coût par portion : 17,08 / 10 = **1,71 €**, inférieur au plafond de 2,00 € (marge de 2,92 € sur le budget de 20,00 €). Le coût est calculé sur les quantités utilisées ; la cinquième boîte de pois chiches entamée et le reste de riz restent au centre social. Remarque : les oranges représentent 4,71 / 17,08 × 100 = 27,6 % du coût ; en été, on les remplacerait par un fruit de saison moins cher.

Question 3 – Fiche technique, fiche « facile à lire », adaptations (3 pts)

Modèle – Fiche technique : pois chiches mijotés aux épinards et à la tomate, riz complet (10 portions)

Ingrédients : pois chiches égouttés 1 200 g ; épinards surgelés 1 000 g ; tomates pelées 800 g ; oignons 333 g bruts ; huile d'olive 60 g ; ail 2 gousses ; cumin 2 cuillères à café ; curcuma 1 cuillère à café ; jus d'un demi-citron ; sel, poivre ; riz complet 600 g.

Matériel : 2 faitouts, 1 casserole pour le riz, planches et couteaux d'office, passoire, cuillères en bois, balance, verre doseur, thermomètre à sonde.

Étapes : 1. Rincer le riz, le cuire 25 à 30 minutes dans 2,5 fois son volume d'eau bouillante. 2. Éplucher et émincer les oignons et l'ail ; les faire revenir 5 minutes dans l'huile. 3. Ajouter les épices, remuer 30 secondes. 4. Ajouter les tomates, cuire 5 minutes. 5. Ajouter les épinards encore surgelés, couvrir 8 à 10 minutes. 6. Ajouter les pois chiches rincés, mijoter 10 minutes ; ajouter le citron, goûter, saler peu. 7. Servir avec le riz.

Points critiques : lavage des mains et des plans de travail ; boîtes de conserve propres, bombées refusées ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C jusqu'au service ; riz cuit refroidi en moins de 2 heures s'il est conservé (risque lié à *Bacillus cereus*) ; ustensiles coupants rangés à plat, pointe vers l'intérieur.

Calcul posé – Lisibilité de la fiche actuelle et de la fiche « facile à lire »

- Fiche actuelle : 150 / 6 = **25** mots par phrase ; 255 / 150 = **1,70** syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 25 − 73,6 × 1,70 = 207 − 25,38 − 125,12 = **56,50** : « assez difficile ».
- Fiche réécrite : 84 / 14 = **6** mots par phrase ; 118 / 84 = **1,405** ; L = 207 − 1,015 × 6 − 73,6 × 1,405 = 207 − 6,09 − 103,40 = **97,51** : « très facile ».

La fiche réécrite remplace les verbes techniques (émincer, faire revenir, déglacer, compoter) par des verbes courants (couper, cuire, mélanger) et chaque étape par **une photo**. Mais l'indice ne vaut que pour les lecteurs : pour les trois apprenants qui ne lisent pas l'alphabet latin, ce sont les **images**, les **objets** et la **démonstration** qui portent le message.

Étape	Ce que montre la photo	Texte court (une phrase)
1	Mains sous le robinet, savon	Je lave mes mains.
2	Couteau qui coupe un oignon sur une planche	Je coupe l'oignon.
3	Oignon dans la casserole avec l'huile, cuillère en bois	Je cuis l'oignon avec l'huile.

Étape	Ce que montre la photo	Texte court (une phrase)
4	Tomates, puis épinards dans la casserole	J'ajoute les tomates et les épinards.
5	Pois chiches dans la passoire sous l'eau, puis dans la casserole	Je rince les pois chiches. Je mélange.
6	Assiette avec riz, pois chiches et une orange à côté	Je sers avec le riz. Je mange l'orange.

Les quantités sont données en **objets** (1 boîte, 1 sachet, 1 oignon, 1 verre de riz pour 2 personnes) ; chaque apprenant peut écrire ou faire écrire, à côté de chaque mot, le mot dans sa langue (lexique personnel).

Adaptations. **Mme A. (grossesse)** : le repas lui convient très bien (fer, vitamine C, fibres) ; laver les oranges avant de les éplucher ; yaourt pasteurisé du commerce (pas de fromage au lait cru au menu) ; cuire les épinards à cœur ; rappeler, sans dramatiser, les aliments à éviter (fromages au lait cru, charcuterie à la coupe, produits de la mer crus) avec des photos. **Mme N. (diabète de type 2)** : garder le riz complet et la portion de 60 g crus, ne pas ajouter de sucre à la salade d'oranges (la cannelle suffit), manger le fruit entier plutôt qu'un jus, servir l'orange à la fin du repas ; pas d'interdit. **Version « à refaire à la maison »** : deux plaques suffisent (une pour le riz, une pour le plat) ; pois chiches en conserve, épinards surgelés et tomates en boîte se gardent longtemps ; le plat se congèle en portions ; variante avec des lentilles corail ou des haricots rouges selon les habitudes de chacun.

Question 4 – Apports d'une portion et commentaire (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (poids nets, Ciqual 2025)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vit. C (mg)
Pois chiches (120 g)	146,4	8,09	18,00	0,60	3,22	6,54	0,65	1,38	0,12
Épinards (100 g)	28,0	3,32	1,00	0,83	0,54	2,95	0,14	1,89	15,30
Tomates (80 g)	13,1	0,72	1,29	1,28	0,22	1,02	0,26	0,46	10,08
Oignon (30 g)	11,7	0,33	1,88	1,44	0,19	0,51	0,03	0	1,17
Huile d'olive (6 g)	53,9	0,01	0	0	5,99	0	0	0	0
Riz complet cru (60 g)	210,0	4,21	42,84	0	1,68	3,00	0,01	0	0
Orange (150 g)	63,0	1,12	12,04	11,40	0	4,05	0	0,85	71,25
Yaourt nature (125 g)	62,6	4,79	5,33	5,00	2,10	0	0,12	0	0
Total	**588,8**	**22,60**	**82,37**	**20,55**	**13,94**	**18,07**	**1,21**	**4,58**	**97,92**

Répartition de l'énergie : protéines 22,60 × 4 / 588,8 × 100 = **15,4 %** ; glucides 82,37 × 4 / 588,8 × 100 = **56,0 %** ; lipides 13,94 × 9 / 588,8 × 100 = **21,3 %** ; les fibres (2 kcal par gramme dans le calcul réglementaire) apportent 18,07 × 2 / 588,8 × 100 = **6,1 %**.

Commentaire. Le repas est rassasiant et économique (1,71 €), riche en **fibres** (18,1 g, soit plus de la moitié des 30 g conseillés par jour), pauvre en **sel** (1,2 g) et en lipides. Les sucres (20,6 g) viennent presque entièrement de l'orange, du yaourt et des légumes : il n'y a pas de sucre ajouté. Les protéines (22,6 g) associent légumineuses, céréale et produit laitier. Pour **Mme A.**, le repas apporte **4,6 mg de fer**, d'origine végétale (non héminique), mieux absorbé grâce aux **98 mg de vitamine C** de l'orange et des légumes servis au même repas ; les épinards et les pois chiches apportent aussi des folates (non chiffrés ici, car absents de l'extrait). Pour **Mme N.**, les glucides (82 g) sont surtout des glucides complexes accompagnés de beaucoup de fibres, ce qui limite l'élévation de la glycémie ; la portion de riz peut être adaptée avec elle.

Question 5 – Littératie, langue et compétences alimentaires (2 pts)

L'atelier développe la **littératie fonctionnelle** (reconnaître des mots, une boîte, une date sur un emballage, avec l'aide des images), la **littératie interactive** (demander, expliquer à son binôme, « faire dire ») et une première **littératie critique** (comparer deux conserves de pois chiches au prix au kilo, se demander si un produit « spécial santé » est utile). Il travaille plusieurs domaines de la **littératie alimentaire** (Vidgen et Gallegos, 2014) : **sélectionner** (lire une conserve), **préparer** (cuire des légumes secs, hygiène), **manger** (repères, partage) et **planifier** (une recette économique à refaire). La **numératie** est abordée par les mesures en objets (un verre, une boîte) et le coût par portion (1,71 €), mieux compris qu'un prix au kilo. Selon les **précautions universelles**, toutes les consignes sont données à l'oral, montrées et illustrées, pour tout le groupe, sans désigner ceux qui ne lisent pas.

Ne pas confondre maîtrise du français et compétences culinaires : ces apprenants savent souvent très bien cuisiner, gérer un budget et nourrir une famille ; leur difficulté porte sur la **langue** et l'**écrit**, pas sur l'alimentation. Les traiter comme des débutants en cuisine serait vexant et ferait perdre une ressource précieuse : on leur demande au contraire de montrer leurs gestes et de raconter leurs plats, ce qui crée du langage.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 15	Mise en place : vérification des denrées et des températures, installation des 4 postes, imagier affiché, objets réels sur une table, riz rincé	–
9 h 15 – 9 h 30	Accueil, prénoms, présentation de l'atelier avec les objets (boîte de pois chiches, sachet d'épinards, orange) ; consignes d'hygiène montrées	Lavage des mains, tablier ; chacun dit comment il cuisine les pois chiches chez lui
9 h 30 – 9 h 45	Imagier : 12 mots et gestes, répétés à voix haute	Répètent, montrent l'objet, disent le mot dans leur langue
9 h 45 – 9 h 55	Démonstration lente : couper l'oignon, rincer les pois chiches	Regardent, un apprenant refait le geste
9 h 55 – 10 h 40	Circule entre les postes, reformule, montre ; lance la cuisson du riz	En binômes (un lecteur et un non-lecteur, langues différentes), réalisent le plat avec la fiche en images
10 h 40 – 10 h 55	Salade d'oranges : montre comment éplucher à vif	Épluchent et coupent les oranges, ajoutent la cannelle
10 h 55 – 11 h 15	Dégustation, grille à smileys, échanges sur les repères (légumes secs, orange et fer)	Goûtent, notent avec les smileys, racontent
11 h 15 – 11 h 30	« Faire dire » et évaluation : chaque binôme montre une étape et nomme 3 mots	Montrent, nomment ; reçoivent la fiche en images
11 h 30 – 11 h 45	Remise en état, plonge, tri des déchets	Participent selon leur envie

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes : démonstration avant l'action ; **apprentissage par le faire** ; répétition des mots en situation (« Je coupe l'oignon ») ; binômes mixtes ; **faire dire** et **faire montrer** plutôt que « Vous avez compris ? ». Outils : imagier de 12 photos (ingrédients et gestes) avec le mot écrit en grand ; objets réels (boîtes, sachets, verres doseurs, morceaux de sucre pour comparer un soda et l'orange) ; fiche recette en 6 photos ; prix par portion affiché en euros. Grille de dégustation sans lecture : pour chaque plat, trois smileys (j'aime, un peu, je n'aime pas) à entourer ou à montrer du doigt, et une question orale « Qu'est-ce que tu changerais ? » ; la formatrice note les réponses.

Question 8 – Hygiène, allergènes, grossesse, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène (méthode des 5 M) : **main-d'œuvre** (lavage des mains montré, cheveux attachés, tablier) ; **milieu** (plans de travail nettoyés et désinfectés) ; **matériel** (planches propres, couteaux rangés) ; **matière** (conserves non

bombées, rinçage des pois chiches, oranges lavées avant épluchage, épinards cuits à cœur) ; **méthode** (marche en avant, riz servi aussitôt ou refroidi rapidement). Allergènes : le yaourt contient du **lait** (affiché par un pictogramme) ; vérifier l'étiquette des épices et de la conserve de pois chiches (traces éventuelles) ; demander oralement à chacun s'il a une allergie. Grossesse : aucune préparation à risque au menu ; on en profite pour montrer les photos des aliments à éviter. Éco-gestes : produits secs et surgelés sans gaspillage, eau de rinçage des légumes réutilisée pour la plonge, épluchures d'orange et d'oignon au compost, cuisson couverte.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Plat : oignons fondants non brûlés, épices torréfiées sans amertume, épinards bien cuits et égouttés, pois chiches entiers et chauds, assaisonnement mesuré ; riz complet tendre et égrené. Salade d'oranges : suprêmes ou rondelles sans peau blanche, cannelle légère. Dressage : assiette avec le riz d'un côté, les pois chiches de l'autre, un peu de persil ; bol d'oranges et yaourt à part.

Question 10 – Évaluation sans écrit (1 pt)

Satisfaction : smileys montrés du doigt. Mots appris : l'imagier présenté au début et à la fin (nombre de mots nommés sur 12) ; exemple de calcul si le groupe nomme en moyenne 36 mots au total au début (36 / 8 = 4,5 mots par personne, 37,5 %) et 75 à la fin (75 / 8 = 9,4 mots, 78,1 %). Gestes et repères : « faire montrer » une étape et « faire dire » pourquoi l'orange accompagne le plat. Intention de refaire : « Tu vas cuisiner ce plat chez toi ? » ; à la séance suivante d'ASL, la formatrice demande qui l'a refait.

Barème – Barème du sujet

Partie 1 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, fiche accessible, lisibilité et adaptations 3 ; apports 2 ; analyse 2. Partie 2 : déroulé 2 ; méthodes et outils 1,5 ; hygiène 1,5. Partie 3 : réalisation 3 ; évaluation 1. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des oranges et des oignons ; calculer le riz avec le poids cuit ; donner une fiche recette seulement écrite ; s'arrêter à l'indice de lisibilité pour un public qui ne lit pas ; traiter les apprenants comme des débutants en cuisine ; donner à Mme N. une liste d'interdits ; ajouter du sucre à la salade d'oranges ; évaluer avec un questionnaire écrit.

Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à comprendre qu'une difficulté d'accès à l'information n'est pas toujours liée à la lecture ou à la langue : ici, elle tient au **handicap visuel** et à l'**inaccessibilité** des supports, des produits et des lieux. Il valorise le calcul juste du rapport de contraste et sa lecture critique, la distinction entre ce qui relève des personnes et ce qui relève de l'environnement, des adaptations construites avec des professionnels de la basse vision, et un atelier où la sécurité et l'autonomie sont travaillées sans infantiliser. Il pénalise les supports seulement visuels, les gestes faits « à la place » des personnes et la conclusion abusive d'un risque relatif non significatif.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête téléphonique (n = 45)

- Ne peut pas lire les dates : 35 / 45 × 100 = **77,8 %**.
- Ne peut pas lire le tableau nutritionnel : 39 / 45 × 100 = **86,7 %**.
- Utilise une application ou un assistant vocal : 17 / 45 × 100 = **37,8 %**.
- Cuisine seul au moins 4 fois par semaine : 28 / 45 × 100 = **62,2 %**.
- Brûlure ou forte peur de se brûler dans l'année : 20 / 45 × 100 = **44,4 %**.
- Mange surtout des plats préparés : 19 / 45 × 100 = **42,2 %**.
- Satisfait de son alimentation : 22 / 45 × 100 = **48,9 %**.
- Taux de participation : 45 / 120 × 100 = **37,5 %**.

Niveau	Constats
Personnes	Impossibilité de lire l'écrit imprimé pour la plupart (77,8 % ne lisent pas les dates) ; perte de confiance en cuisine (44,4 % de brûlures ou de peur) ; repli sur les plats préparés (42,2 %) ; compétences anciennes à réactiver (Mme L.) ; usage partiel d'outils numériques (37,8 %)
Produits	Dates, prix et tableaux imprimés en petits caractères, souvent sans contraste ; applications de lecture qui lisent tout l'emballage sans hiérarchie (M. T.)
Environnement	Supports de prévention illisibles (dépliant, affiche, site) ; aide en magasin dépendante de la bonne volonté du personnel (Mme G.) ; isolement (58 % vivent seuls)

Diagnostic. L'information alimentaire est **inaccessible** pour la grande majorité des adhérents, non par manque de compétences mais parce que les supports ne sont pas conçus pour eux. Cette inaccessibilité, associée à la peur de se blesser, conduit près d'un adhérent sur deux à se replier sur des plats préparés et à se dire peu satisfait de son alimentation. Le taux de participation (37,5 %) invite à la prudence : les répondants sont peut-être les adhérents les plus actifs.

Question 2 – Contraste et accessibilité des supports (2,5 pts)

Calcul posé – Rapport de contraste (WCAG)

- Support A : (1,000 + 0,05) / (0,216 + 0,05) = 1,05 / 0,266 = **3,95** : inférieur à 4,5, **non conforme** pour un texte courant ; la police de 9 points aggrave le problème.
- Support B : (1,000 + 0,05) / (0,927 + 0,05) = 1,05 / 0,977 = **1,07** : contraste presque nul, **non conforme**, même pour un grand texte (seuil 3).
- Support C : (1,000 + 0,05) / (0,000 + 0,05) = 1,05 / 0,05 = **21,0** : contraste maximal, **conforme** ; police de 16

points.
- Site de la mairie : 5 / 12 × 100 = **41,7 %** des critères respectés ; en ajoutant les textes alternatifs, des liens explicites, les sous-titres et l'audiodescription de la vidéo, et une police agrandissable, on atteindrait par exemple 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.

Corrections : texte noir (ou très foncé) sur fond clair uni, ou l'inverse ; police sans empattement de 16 points au moins ; pas d'information donnée seulement par la couleur ; version numérique accessible au lecteur d'écran (titres structurés, textes alternatifs) ; version audio ; pour l'association, version en braille pour les adhérents qui le lisent. L'**indice de Kandel et Moles** mesure la longueur des phrases et des mots : un texte « très facile » au sens de cet indice reste **illisible** s'il est imprimé en gris pâle de 9 points, ou s'il n'existe qu'en image. Pour ce public, l'accessibilité passe par le **format** (contraste, taille, audio, braille, compatibilité avec le lecteur d'écran) autant que par la clarté du texte.

Question 3 – Analyse avec les notions du chapitre (2 pts)

- **Modèle de Sørensen** : la difficulté se situe surtout à l'étape **accéder** (l'information est là, mais impossible à percevoir) ; **comprendre** et **évaluer** sont peu touchés quand l'information est rendue audible ; **appliquer** est freiné par la peur de se blesser.
- **Littératie alimentaire** : les compétences de **préparation** existent ou ont existé (Mme L.) ; la **sélection** (dates, prix, composition) est empêchée par l'étiquetage ; la **planification** est compliquée par la difficulté à faire ses courses seul.
- **Littératie numérique** : les outils (lecteur d'écran, reconnaissance de texte) sont de vraies aides, mais ils demandent un apprentissage et lisent tout sans hiérarchie : il faut apprendre à les utiliser et à chercher l'information utile (date, allergènes).
- **Littératie organisationnelle** : la mairie, le supermarché et les fabricants ont la responsabilité de rendre l'information accessible (loi de 2005, RGAA, Acte européen sur l'accessibilité depuis 2025).
- **Précautions universelles** : un support conçu pour être lisible par des personnes malvoyantes (contraste, taille, audio) est plus lisible pour tous, en particulier pour les personnes âgées.

Question 4 – Objectifs, plan d'action et budget (4 pts)

Objectif général : améliorer l'autonomie alimentaire et la sécurité en cuisine des adhérents de l'association, en un an.

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : permettre aux adhérents de lire les informations utiles des emballages (dates, allergènes, prix)	Part des adhérents qui déclarent pouvoir lire les dates (avec ou sans outil)	22,2 %	50 %	12 mois
Spécifique 2 : renforcer la sécurité et la confiance en cuisine	Part des adhérents qui déclarent une brûlure ou une forte peur de se brûler	44,4 %	30 %	12 mois
Opérationnel 1 : animer 8 ateliers culinaires adaptés de 6 personnes avec l'ergothérapeute	Nombre d'ateliers et de participants	0	8 ateliers, 30 adhérents différents	10 mois
Opérationnel 2 : organiser 4 sessions d'apprentissage d'une application de lecture d'étiquettes gratuite	Nombre de participants capables de lire une date avec l'application	0	20	6 mois
Opérationnel 3 : produire 10 recettes en version audio et en gros caractères à fort contraste	Nombre de recettes ; contraste ≥ 4,5 ; test auprès de 5 adhérents	0	10 recettes testées	8 mois
Opérationnel 4 : obtenir du supermarché une aide aux courses sur rendez-vous et du centre communal d'action sociale une version accessible de ses supports	Conventions ou engagements signés	0	2	12 mois

Poste	Coût
Denrées pour 8 ateliers (environ 25 € par atelier, plus 300 € pour les repas partagés)	500 €
Matériel adapté (gants anti-chaleur longs, planches contrastées, couteaux protégés, détecteur de niveau de liquide, minuteurs parlants, étiquettes en relief)	300 €
Enregistrement audio et impression en gros caractères des recettes	240 €
Transcription en braille (prestataire)	280 €
Sessions d'apprentissage numérique (bénévoles formés, matériel de démonstration)	200 €
Transport accompagné pour les participants isolés	180 €
Formation courte des bénévoles au guidage	150 €
Communication et événement de restitution	150 €
Total	**2 000 €**

Vérification : 500 + 300 + 240 + 280 + 200 + 180 + 150 + 150 = **2 000 €** ✓.

Question 5 – Risque relatif, intervalle de confiance et taille d'échantillon (3 pts)

Calcul posé – Brûlures selon la cuisine solitaire

Notations : a = 16, a + b = 28 ; c = 4, c + d = 17.

- Risque chez ceux qui cuisinent seuls au moins 4 fois par semaine : 16 / 28 = **57,1 %** ; chez les autres : 4 / 17 = **23,5 %**.
- RR = 0,571 / 0,235 = **2,43**.
- ln RR = 0,887 ; erreur type = √(1/16 − 1/28 + 1/4 − 1/17) = √0,2180 = **0,467**.
- IC 95 % = exp(0,887 ± 1,96 × 0,467) = exp(0,887 ± 0,915) = [exp(− 0,028) ; exp(1,802)] = **[0,97 ; 6,06]**.

Le risque est 2,4 fois plus élevé chez les adhérents qui cuisinent souvent seuls, mais l'intervalle de confiance **contient 1** : l'association n'est **pas statistiquement significative** au seuil de 5 % avec seulement 45 répondants. On ne peut donc ni conclure à un lien ni l'exclure. Interprétation logique : plus on cuisine, plus on s'expose au risque ; cela ne veut pas dire qu'il faut cuisiner moins, mais qu'il faut cuisiner **en sécurité**.

Calcul posé – Proportion d'adhérents qui ne peuvent pas lire le tableau nutritionnel

- p = 39 / 45 = **0,867** ; demi-largeur = 1,96 × √(0,867 × 0,133 / 45) = 1,96 × √0,002567 = 1,96 × 0,0507 = **0,099**.
- IC 95 % = **[76,7 % ; 96,6 %]**.
- n0 = 1,96² × 0,867 × 0,133 / 0,05² = **178** ; correction pour 120 adhérents : n = 178 / (1 + 177 / 120) = 178 / 2,475 = **72** adhérents.

Question 6 – Veille (2 pts)

Sources : Fédération des aveugles et amblyopes de France et grandes associations nationales de la déficience visuelle (guides d'accessibilité) ; direction interministérielle du numérique (RGAA) ; W3C (WCAG) ; Défenseur des droits ; Santé publique France (« Communiquer pour tous ») ; Haute Autorité de santé ; centres de rééducation basse vision ; textes européens sur l'accessibilité. Outils : lettres d'information, alertes, flux RSS **compatibles avec le lecteur d'écran**. Fréquence : mensuelle pour les textes et les outils ; à chaque projet pour les guides. Diffusion : synthèse audio et en gros caractères pour le bureau de l'association.

Question 7 – Situations éthiques et accessibilité de l'exposé (2 pts)

- **Financement contre recommandation d'une application payante** : conflit d'intérêts ; l'association ne peut pas recommander un produit en échange d'un financement ; il existe des applications gratuites, et le choix

doit se faire selon les besoins de chacun. Réponse : refus du financement conditionnel ; un partenariat serait possible sans contrepartie publicitaire, avec une information sur plusieurs outils.

- **Vidéo diffusée publiquement** : **droit à l'image** ; il faut l'autorisation écrite de chaque personne filmée, après une information claire (et accessible : lue à voix haute) sur la diffusion ; le respect de la dignité exclut les images de gestes maladroits ou d'accidents. On peut proposer une vidéo centrée sur les mains et les ustensiles, avec audiodescription, validée par les participants.
- **Exposé accessible** : diaporama à fort contraste, police de grande taille, chaque visuel **décrit oralement** ; documents remis en version numérique accessible au lecteur d'écran ; présence possible d'un adhérent pour témoigner.

Temps 2 – L'atelier culinaire

Question 8 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : retrouver la confiance et la sécurité pour cuisiner ; recevoir l'information sous une forme accessible (orale, tactile, gros caractères) ; partager un repas (isolement) ; tenir compte du diabète de Mme L. et de l'hypertension de M. B. Objectif général : permettre aux participants de réaliser en sécurité un repas complet et simple, qu'ils pourront refaire seuls chez eux. Objectifs opérationnels : 1. chaque participant utilise au moins deux aides techniques (gant long, détecteur de niveau, minuteur parlant) ; 2. chaque participant réalise seul, après démonstration tactile, une étape de la recette (râper, mesurer la semoule, verser l'eau chaude, enfourner) ; 3. chaque participant décrit à l'oral la composition de son assiette en se repérant « en horloge ».

Question 9 – Bon de commande, coût et apports (4 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Coût
Filet de poulet	1 000 g	0 %	1 000 g	1,000 × 11,50 = 11,50 €
Yaourt nature	300 g	0 %	300 g (3 pots de 100 g ou 2,4 pots de 125 g)	0,300 × 2,20 = 0,66 €
Citron (jus)	50 g	60 %	50 / 0,40 = 125 g (1 citron)	0,125 × 3,00 = 0,38 €
Huile de colza	50 g	0 %	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Semoule	600 g	0 %	600 g	0,600 × 1,90 = 1,14 €
Carottes	1 000 g	15 %	1 000 / 0,85 = 1 176 g	1,176 × 1,40 = 1,65 €
Oranges à jus (jus)	300 g	55 %	300 / 0,45 = 667 g	0,667 × 2,00 = 1,33 €
Bananes	800 g	35 %	800 / 0,65 = 1 231 g	1,231 × 2,00 = 2,46 €
Fromage blanc 2-3 %	1 000 g	0 %	1 000 g	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Ail, épices, persil, sel	–	–	–	0,90 €

Total : 11,50 + 0,66 + 0,38 + 0,16 + 1,14 + 1,65 + 1,33 + 2,46 + 2,60 + 0,90 = **22,78 €** ; par portion : **2,28 €**, sous le plafond de 2,50 €.

Calcul posé – Apport d'une portion (Ciqual 2025)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet (100 g)	110,0	23,40	0	0	1,50	0	0,11
Yaourt (30 g)	15,0	1,15	1,28	1,20	0,50	0	0,03
Jus de citron (5 g)	1,5	0,02	0,30	0,12	0,01	0,02	0
Huile de colza (5 g)	45,0	0	0	0	5,00	0	0
Semoule crue (60 g)	210,0	7,08	41,88	0,60	0,77	2,22	0
Carotte (100 g)	30,2	0,78	5,16	4,85	0	2,90	0,12

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Jus d'orange (30 g)	13,6	0,18	2,88	2,88	0,03	0,08	0
Banane (80 g)	70,1	0,85	15,76	12,48	0	2,16	0
Fromage blanc (100 g)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,02	0,09
Total	**571,1**	**40,74**	**71,13**	**25,99**	**11,05**	**7,40**	**0,36**

Répartition : protéines 40,74 × 4 / 571,1 × 100 = **28,5 %** ; glucides 71,13 × 4 / 571,1 × 100 = **49,8 %** ; lipides 11,05 × 9 / 571,1 × 100 = **17,4 %.**

Commentaire : repas riche en protéines (poulet et fromage blanc), pauvre en lipides et très pauvre en sel (0,36 g sans sel ajouté), avec des fibres modérées (7,4 g) qu'on pourrait augmenter avec une semoule complète ou des pois chiches dans la semoule. Les sucres (26 g) viennent de la banane, des carottes, du jus d'orange et du fromage blanc : aucun sucre ajouté. Pour **Mme L.** (diabète), le dessert ne contient pas de sucre ajouté ; la banane bien mûre élève plus la glycémie qu'une banane juste mûre ; la portion de semoule peut être ajustée avec elle. Pour **M. B.** (hypertension), le repas est un bon exemple de plat savoureux sans sel ajouté grâce au citron, à l'ail, au cumin et au persil : on sale à table, avec modération, après avoir goûté.

Question 10 – Fiche technique, recette accessible, adaptations (4 pts)

Modèle – Fiche technique : poulet mariné au yaourt et au citron, semoule, carottes râpées à l'orange (10 portions)

Ingrédients : 1 kg de filets de poulet ; 300 g de yaourt ; jus d'un citron ; 2 gousses d'ail ; 2 cuillères à café de cumin ; 50 g d'huile ; 600 g de semoule ; 600 mL d'eau bouillante ; 1,2 kg de carottes ; jus de 3 oranges ; persil ; 1 kg de fromage blanc ; 1,2 kg de bananes ; cannelle.

Étapes : 1. Couper le poulet en lanières (fait par le candidat ou un bénévole avant l'atelier, ou par un participant avec un couteau à garde et une planche contrastée). 2. Mélanger yaourt, citron, ail, cumin ; enrober le poulet ; laisser mariner 30 minutes au réfrigérateur. 3. Cuire au four à 200 °C pendant 18 à 20 minutes ; vérifier 75 °C à cœur avec un thermomètre parlant. 4. Verser l'eau bouillante sur la semoule avec l'huile, couvrir 5 minutes, égrener à la fourchette. 5. Râper les carottes avec une râpe à réservoir, arroser de jus d'orange. 6. Écraser les bananes à la fourchette, mélanger au fromage blanc, saupoudrer de cannelle.

Points critiques : volaille crue séparée et ustensiles dédiés ; cuisson à cœur ; liquide bouillant ; four chaud ; lames.

Version accessible de la recette : **audio** (enregistrement de 3 minutes, une étape par piste, phrases courtes, quantités en objets : « un pot de yaourt », « un verre de semoule par personne ») ; **gros caractères** (police sans empattement de 18 points, noir sur jaune pâle ou blanc sur noir, une étape par page) ; **braille** pour les adhérents qui le lisent ; **repères tactiles** (gommettes en relief sur le bouton du four à 200 °C, élastique sur le flacon de cumin).

Adaptations proposées avec l'ergothérapeute : poste toujours organisé de la même façon (ingrédients à gauche, outils à droite, « ce qui est utilisé retourne à sa place ») ; plateau à rebords pour contenir les débordements ; planche de couleur contrastée (blanche pour les carottes, noire pour l'oignon) ; **râpe à réservoir** et gant anti-coupure ; **détecteur de niveau de liquide** sur la tasse pour verser l'eau bouillante, bouilloire posée sur un plateau ; **gants longs** pour le four, grille sortie avant de saisir le plat ; minuteur parlant ; doigt guide et gestes « main sur main » proposés seulement avec l'accord de la personne.

Question 11 – Déroulé, méthodes et dégustation (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 15	Mise en place : postes identiques, ustensiles alignés, détecteurs et minuteurs testés, poulet découpé si besoin	–
9 h 15 – 9 h 35	Accueil, présentation orale de chacun ; visite tactile du poste (« la planche est devant vous, le couteau à droite, pointe vers le mur »)	Explorent le poste avec les mains
9 h 35 – 9 h 50	Marinade : description précise des gestes, démonstration tactile	Mélangent la marinade, enrobent le poulet
9 h 50 – 10 h 20	Carottes et bananes : utilisation de la râpe à réservoir et du gant	Râpent, écrasent, mélangent
10 h 20 – 10 h 45	Four : enfourner avec l'ergothérapeute ; semoule avec le détecteur de niveau	Enfournent à tour de rôle, versent l'eau chaude
10 h 45 – 11 h 05	Pendant la cuisson : échange sur les applications de lecture d'étiquettes (démonstration sur une boîte de semoule)	Lisent une date avec l'application
11 h 05 – 11 h 45	Service, repérage de l'assiette « en horloge » (poulet à midi, semoule à 4 h, carottes à 8 h), repas partagé, dégustation orale	Décrivent, goûtent, commentent
11 h 45 – 12 h 00	« Faire dire » et « faire faire » : chacun explique une astuce de sécurité	Expliquent ; reçoivent la recette audio
12 h 00 – 12 h 15	Remise en état	Participent

Méthodes : **guidage verbal précis** (positions, distances, « à votre droite », jamais « là ») ; démonstration tactile ; **main sur main** seulement avec accord ; « faire dire » (« Comment allez-vous savoir que le poulet est cuit ? ») et « faire faire ». Grille de dégustation orale : pour chaque plat, une note de 1 à 5 dite à voix haute, et deux questions (« Qu'avez-vous aimé ? » ; « Que changeriez-vous ? »), notées par un bénévole.

Question 12 – Hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes (3 pts)

Hygiène : lavage des mains guidé (savon et serviette toujours au même endroit) ; volaille crue sur une planche dédiée, puis lavage des mains ; marinade au réfrigérateur ; cuisson à cœur (75 °C) vérifiée au thermomètre parlant ; produits laitiers au froid. Sécurité : rangement constant ; couteaux rangés à plat dans un bac ; jamais de liquide chaud porté à bout de bras ; poignées des casseroles tournées vers l'intérieur ; four ouvert par l'animateur ou avec l'ergothérapeute ; annonce orale de chaque déplacement (« Je passe derrière vous avec le plat chaud »). Allergènes : **lait** (yaourt, fromage blanc), **gluten** (semoule de blé) ; signalés oralement et en gros caractères. Éco-gestes : carottes et bananes de saison ou de proximité si possible ; épluchures au compost ; four utilisé à pleine charge ; restes répartis en boîtes pour les participants.

Question 13 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation : poulet doré, tendre et cuit à cœur ; semoule égrenée ; carottes finement râpées, juteuses ; dessert onctueux, banane non oxydée (préparée au dernier moment ou citronnée). Évaluation : nombre d'aides techniques utilisées par chaque participant ; nombre d'étapes réalisées seul ; incidents (brûlure, coupure : objectif zéro) ; notes de dégustation ; question « Pensez-vous refaire une partie de ce repas chez vous ? » ; appel téléphonique trois semaines plus tard : « L'avez-vous refait ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? ».

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs et diagnostic 2,5 ; contraste et accessibilité 2,5 ; analyse 2 ; objectifs, plan et budget 4 ; statistiques 3 ; veille 2 ; éthique et exposé 2 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande et apports 4 ; fiche technique, recette accessible et adaptations 4 ; déroulé, méthodes et dégustation 4 ; hygiène et sécurité 3 ; réalisation et évaluation 3 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Inverser L1 et L2 dans le calcul du contraste ; conclure que le support A est « presque conforme » ; s'arrêter à la lisibilité du texte sans regarder le format ; conclure à un lien significatif alors que l'intervalle contient 1 ; faire les gestes à la place des participants ; guider avec des mots comme « ici » ou « là » ; oublier les pertes du citron, des oranges et des bananes ; oublier le gluten de la semoule ; accepter une recommandation commerciale en échange d'un financement.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des indicateurs de littératie et d'accès à l'information ; comparer avec HLS19	S1, S3			
C3.1	Classer des difficultés selon le modèle de Sørensen et les niveaux de Nutbeam	S1, S3			
C3.1	Calculer un indice de lisibilité et l'interpréter avec un test de compréhension	S1, S2			
C3.1	Calculer un rapport de contraste et un taux de conformité d'accessibilité	S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 (dont fer et vitamine C) et les commenter	S2, S3			
C3.2	Concevoir une fiche recette accessible (images, objets, audio, gros caractères, braille)	S2, S3			
C3.2	Adapter un atelier à des apprenants allophones et à des personnes déficientes visuelles	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène et la sécurité (conserves, riz cuit, volaille, brûlures, coupures)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; distinguer significatif et non significatif	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille sur la littératie, l'accessibilité et un public spécifique	S1, S3			
C3.5	Choisir des supports et des canaux adaptés (oral, vidéo, audio, pictogrammes, médiation)	S1, S2, S3			
C3.6	Respecter le secret professionnel, les données personnelles, le droit à l'image ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.